Faculté de médecine d'Oran
Annexe de médecine de TIARET

Les péricardites

MODULE DE SÉMIOLOGIE
3EME ANNÉE MÉDECINE

Dr TALEB
Service de médecine interne EHU Oran

Définition

- C’est l’ensemble des affections inflammatoires de l’enveloppe séreuse du péricarde

- Inflammation des deux feuillets (pariétal et viscérale) de la séreuse péricardique avec ou sans épanchement

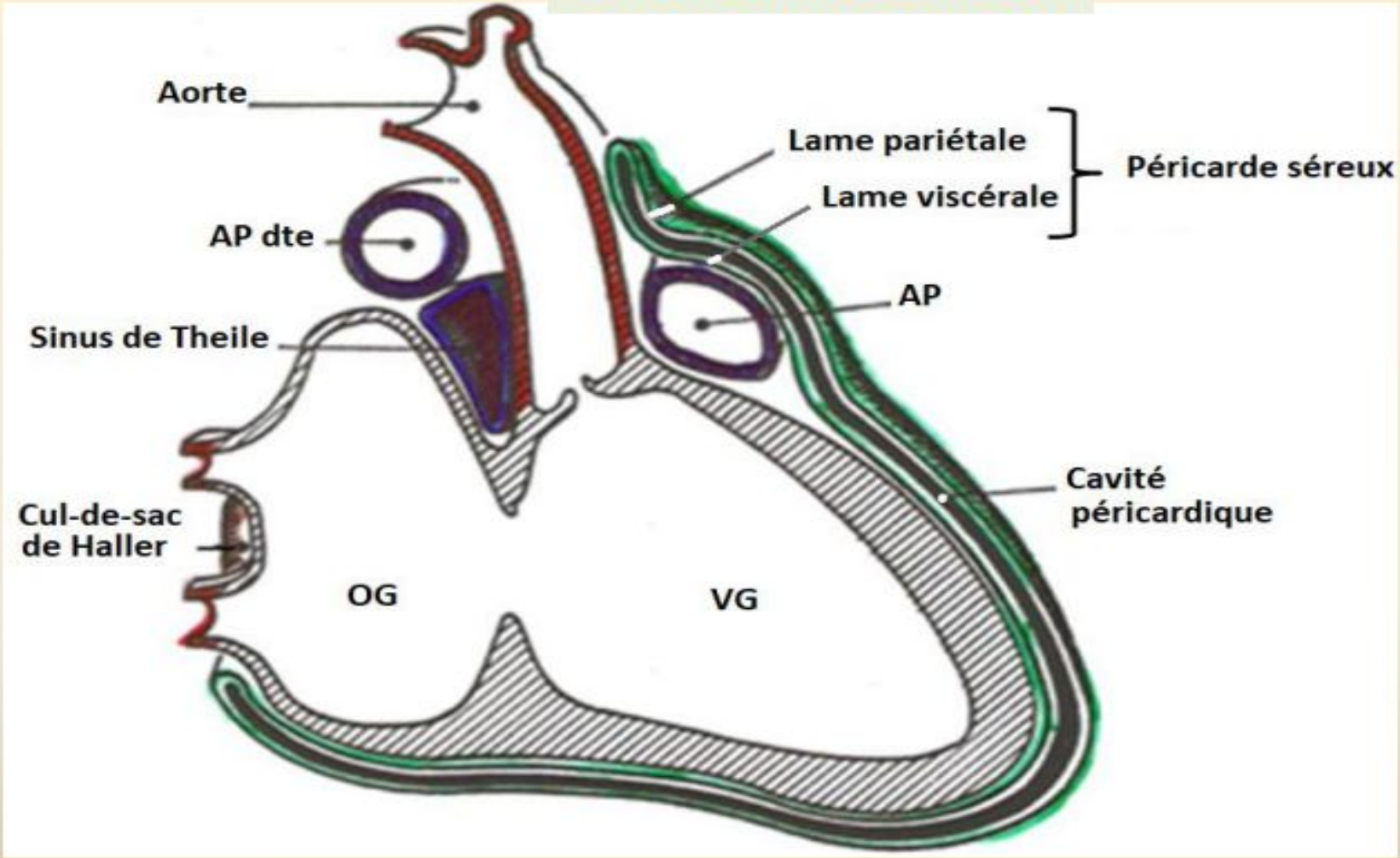
Rappel Anatomique

- Le péricarde est formé d'une enveloppe externe fibreuse et d'une enveloppe interne, la séreuse péricardique.

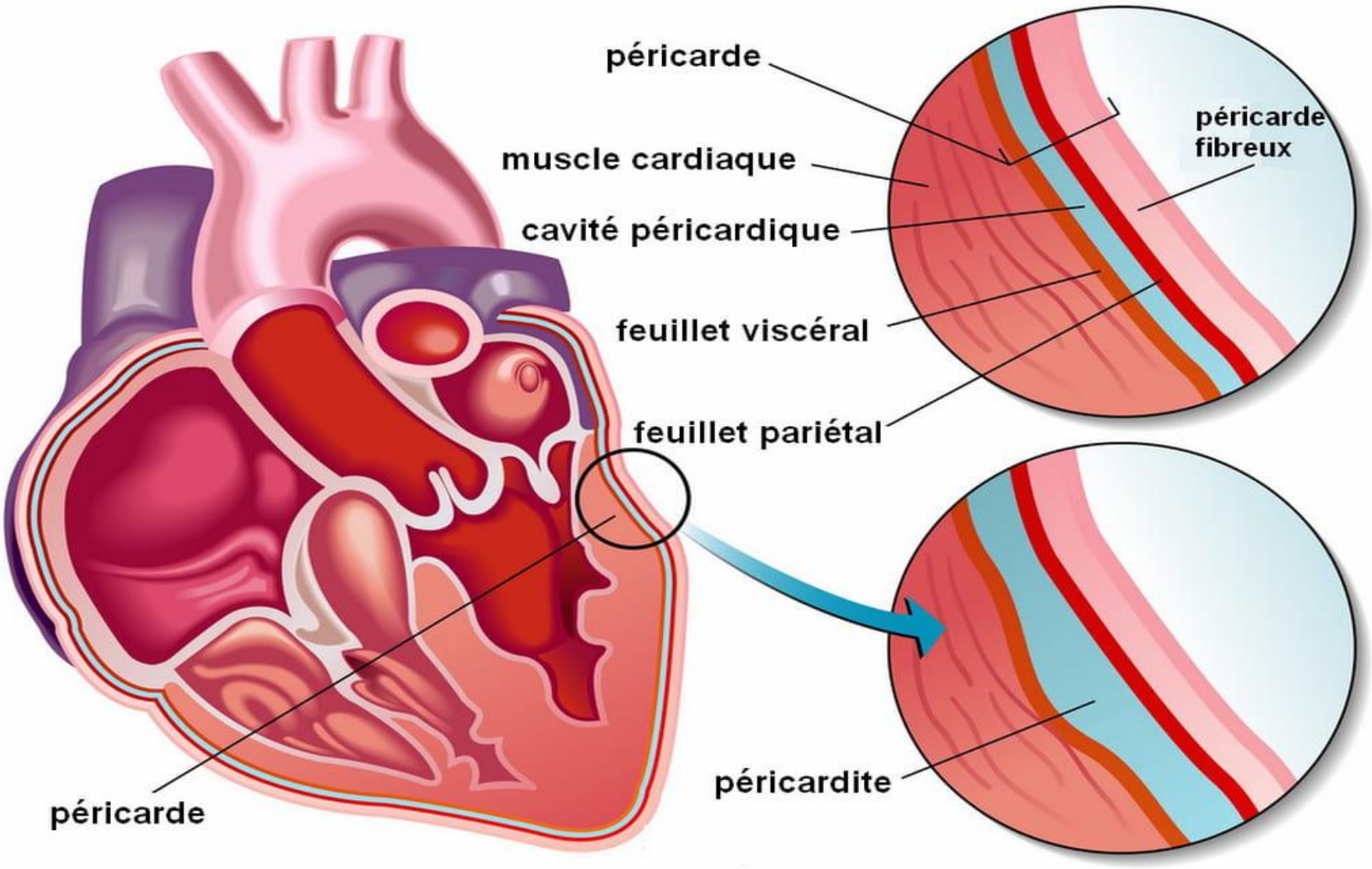
- Elle comprend 2 feuillets ***viscéral et pariétal***

  Entre ces deux feuillets existe une cavité 20-50 ml

LE PÉRICARDE SÉREUX



Coupe sagittale du cœur


péricarde
muscle cardiaque
cavité péricardique
feuillet viscéral
feuillet pariétal
péricarde
péricarde fibreux
péricarde
péricardite

Anatomie pathologique

Remaniements inflammatoires

- Afflux de polynucléaires neutrophiles et de lymphocytes, associés à un dépôt de fibrine et une sécrétion liquidienne par la séreuse

- la surface devient congestive, rugueuse, souvent recouverte de fausses membranes

Formes cliniques

1. Péricardite aigue : qui peut être sèche, fibrineuse, ou avec épanchement.

2. Péricardite chronique qui dure au-delà de 3 mois.

3. Péricardite récidivante : avec deux formes

A. *Intermittente* : les épisodes de péricardite sont séparés par un intervalle sans symptômes entre les traitements.

B. *Incessante* : récidive des péricardites dès l'arrêt du traitement.

4. Epanchement péricardique
avec ou sans tamponnade cardiaque

5. Péricardite constrictive

EXAMEN CLINIQUE

Signes Généraux

- Pas constants
- Motif de consultation ++
- Si présents modérés : Fièvre; asthénie; contexte infectieux précédant de quelques jours

Signes fonctionnels

1-Douleurs thoraciques (95%)



- Siege : Rétrosternal / précordia
- Début : Brutal
- Intensité : Violente
- Type : Point de coté, parfois brulure.
- Irradiation : Rarement vers les bras, dos, épaules
- Durée : Persiste plusieurs heures voire jours
- Exacerbation :Inspiration profonde,décubitus dorsal

Signes fonctionnels

2-Dyspnée

Plus souvent modérée en rapport avec la douleur,

Plus nette en décubitus et soulagée par la position assise.

3- Contexte infectieux

Fièvre, toux sèche, rhinorrhée

Signes physiques

L'examen clinique est pauvre, plus souvent normal

Rechercher le frottement péricardique +++

Pathognomonique mais inconstant !

Auscultation : bruit surajouté, au deux temps du cycle cardiaque, localisé et superficiel

« crissement cuire neuf » « pas sur la neige »

Persiste en apnée ≠ frottement pleural

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

L'électrocardiogramme

=> Peut être normal

Les signes électriques évoluent en 4 stades de Holzmann

Stade I (<24h) : sus décalage de segment ST concave vers le haut

Stade II (<48h): retour du ST à la ligne isoélectrique avec aplatissement des ondes T

Stade III (<7j): Négativation de T du type ischémie sous-épicardique

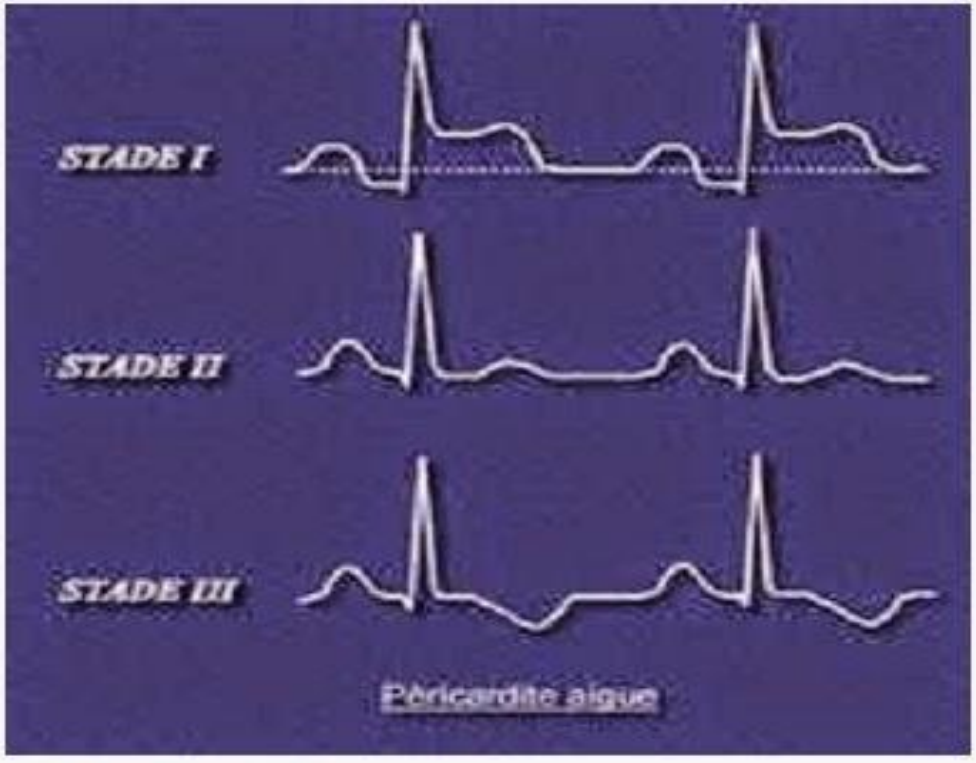
Stade IV (<2mois): retour de l'ECG à l'état normal.

Les anomalies de repolarisation sont diffuses et pas de d'images en miroir

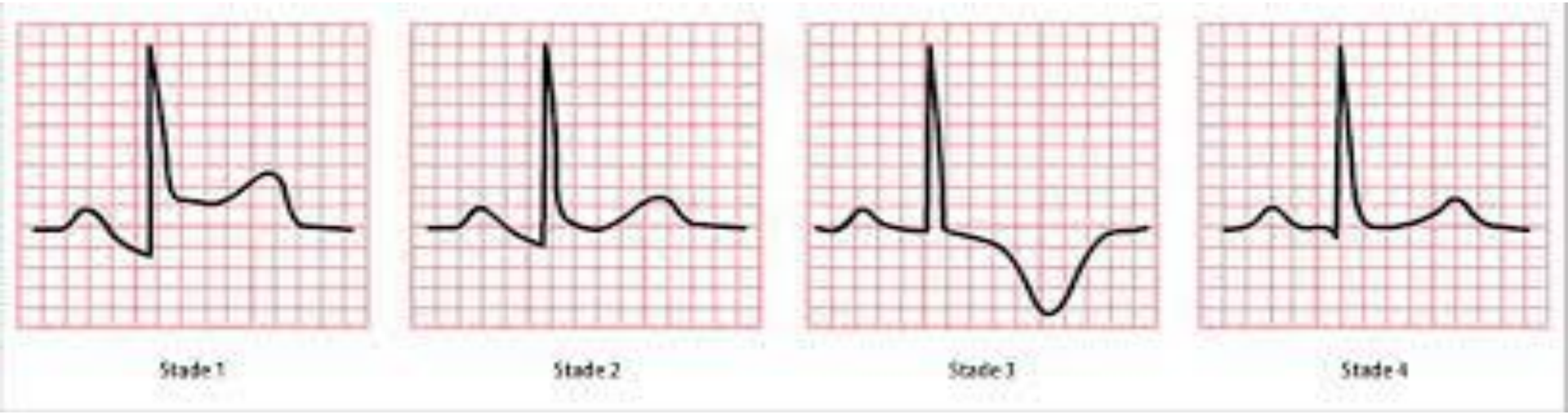
Autres signes

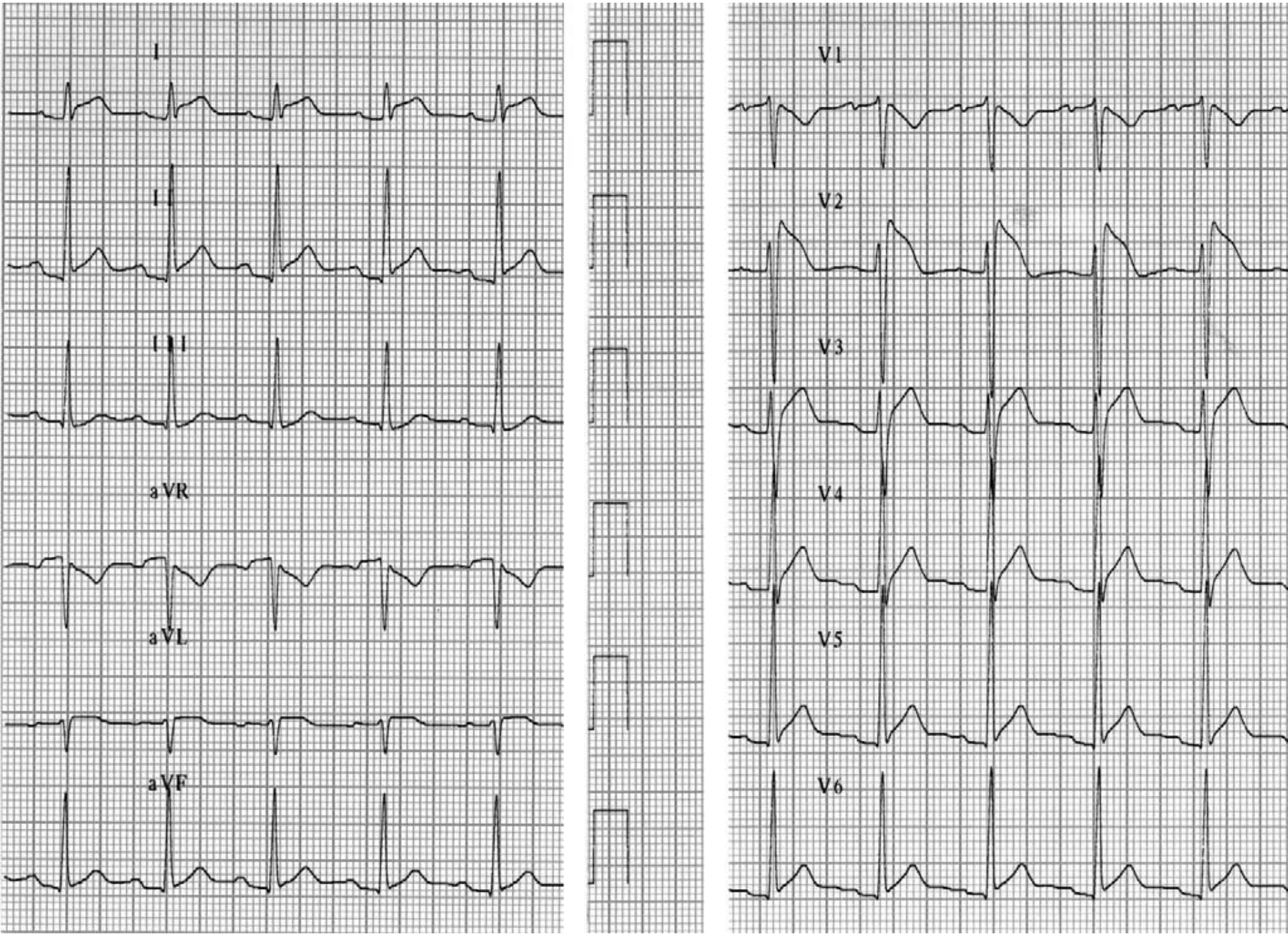
Sous décalage de PQ, microvoltage, alternance électrique

- *1ères H* — *surélévation du segment ST, concave en haut*
- *24 - 48 H* — *onde T + ou aplatie*
- *> 2ème S* — *onde T négative*



- ***Stade IV :*** *retour à la normale*




I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Radiologie thoracique

N'est significative que dans les péricardites avec épanchement



- Augmentation du volume cardiaque

- Augmentation des dimensions
de l'ombre cardiaque
Donnant un aspect triangulaire
et symétrique (coeur en carafe ou théière

- Parfois, épanchement pleural, surtout gauche.

Echocardiographie

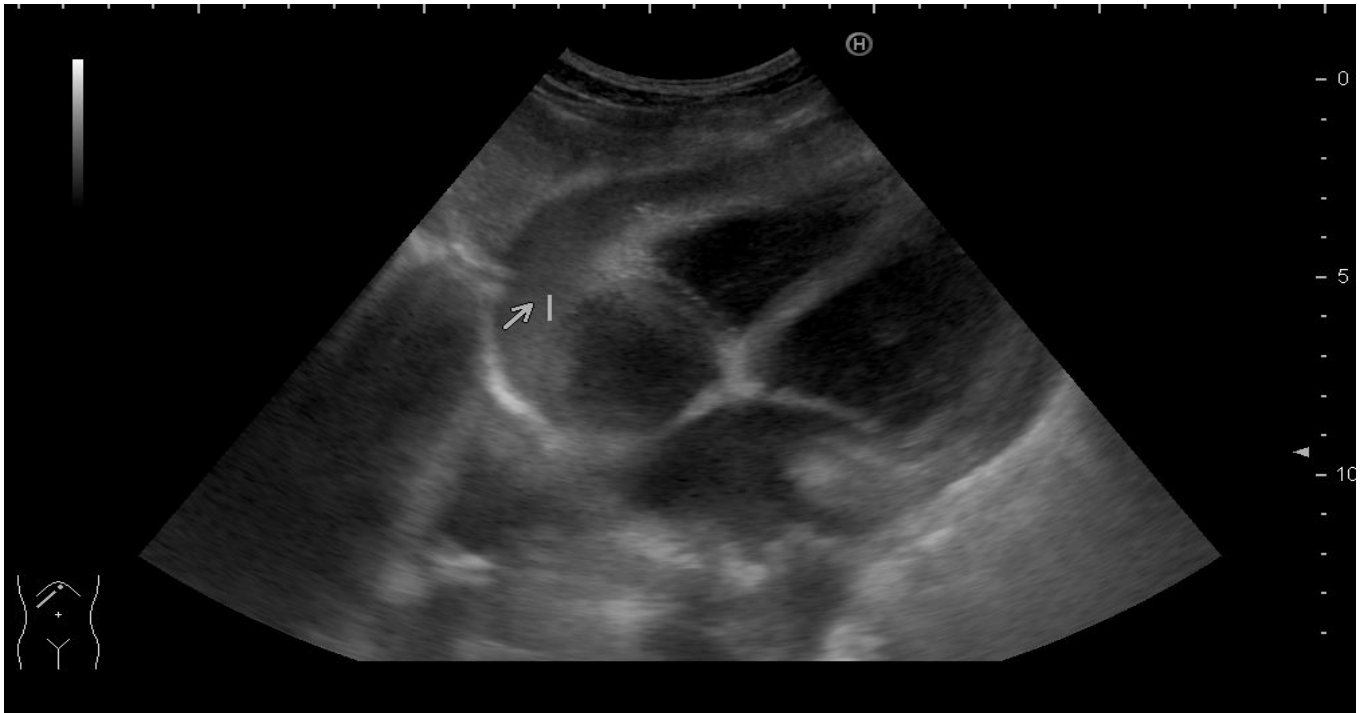
- Peut être normal
- Examen clé pour affirmer l'épanchement +++
- Apprécie l'état hémodynamique
- Guider la ponction péricardique
- Permet la surveillance / évolution

Epanchement péricardique minime



Epanchement péricardique majeur





Examens biologiques

FNS Hyperleucocytose

Syndrome inflammatoire (VS / CRP / EPS/ fibrinogène)

Marqueurs nécrose CK / troponines

Diagnostic positif

Diagnostic de la péricardite aiguë retenu en présence de ≥ 2 critères

- Douleur thoracique
- Frottement péricardique
- Modifications ECG
- Epanchement péricardique

Critères de gravité (Majeurs)

- Une fièvre > 38° C
- Une installation subaiguë
- Un épanchement péricardique important
- Une tamponnade
- L'absence de réponse à l'aspirine ou aux AINS après au moins une semaine de traitement

Critères de gravité (Mineurs)

- Myopéricardites
- Un état d'immunosuppression
- Un traumatisme
- Patient sous traitement anticoagulant oral

Les étiologies

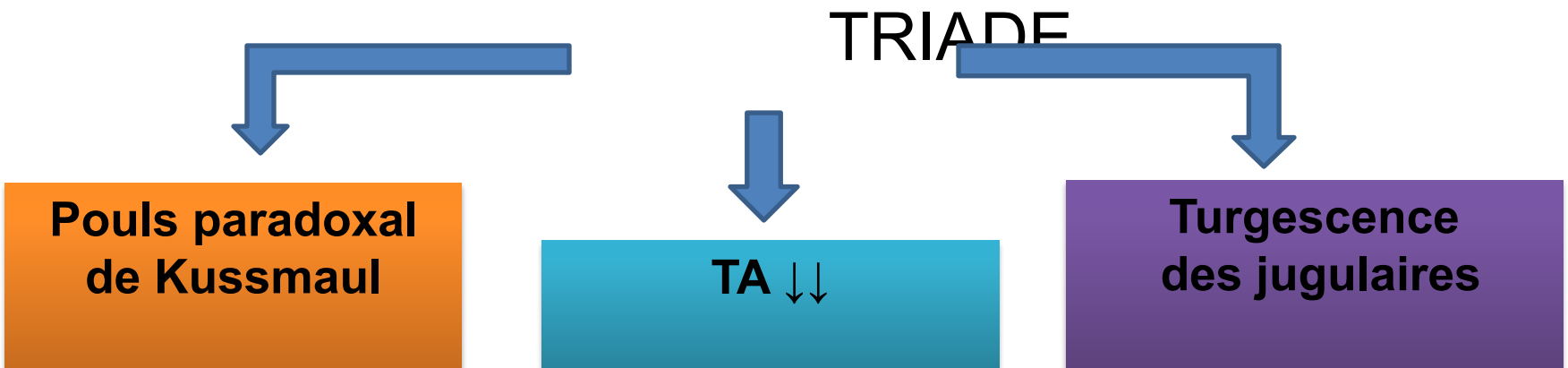
- Infectieuses -Virales +++ - Tuberculeuse +
  - Bactériennes – parasitaires
- Auto-immunes / médicamenteuses
- néoplasiques
- Métaboliques urémique / myxœdème
- Traumatique / Post IDM / Chirurgie cardiaque

Tamponnade péricardique

La constitution rapide d'un épanchement secondaire a une péricardite sèche, ou épanchement d'emblée de grande abondance

Tableau d'adiastolie ========> URGENCE VITALE !!

Compression des cavités cardiaques (droites +++)



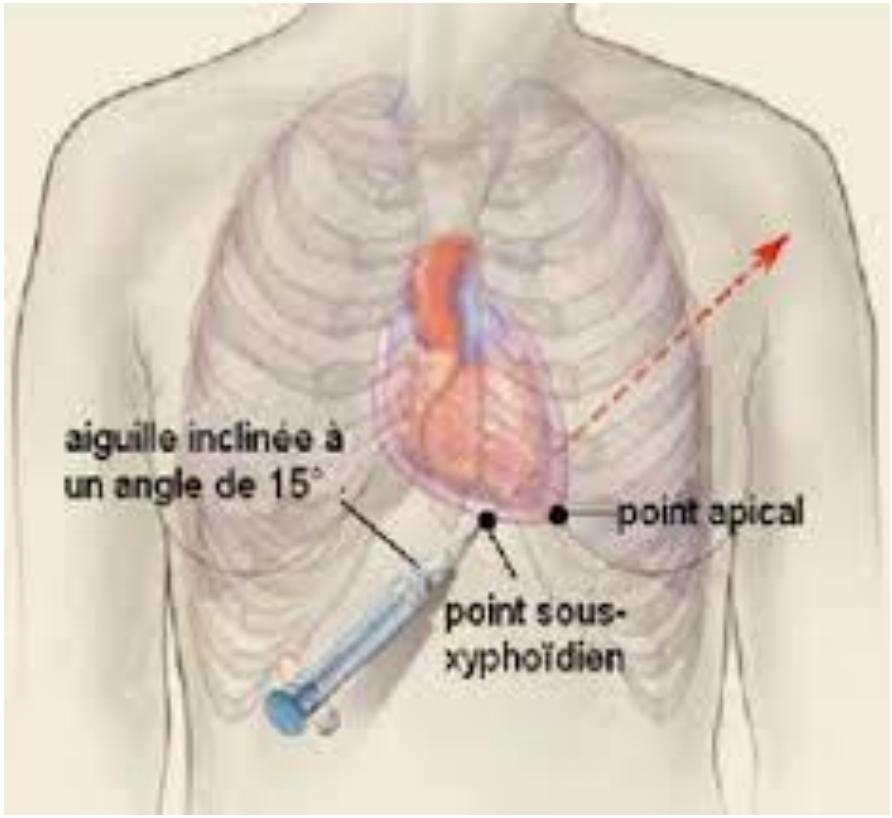
Tamponnade péricardique

Le diagnostic est fait par l'échocardiographie

- *Epanchement volumineux*
- *Circonférentiel (Swinging Heart)*
- *Ecrasement des cavités droites*

La ponction péricardique





Le drainage péricardique



